

Public Domain und Open Source ist die bessere Grundlage für Innovation und gesunden Wettbewerb

► Vor über zwanzig Jahren stellte ich mir eine einfache Frage: Wem gehören eigentlich die Arzneimittel-Informationen, die jede Ärztin und jeder Apotheker täglich braucht? Die von Swissmedic geprüften Fach- und Patienteninformationen entstehen im Rahmen eines staatlichen Zulassungsverfahrens. Sie sind die Grundlage jeder sicheren Verschreibung. Und doch wurden sie jahrelang behandelt, als wären sie das private Eigentum eines einzigen Unternehmens.

Als ich diese Daten über die quelloffene Plattform oddb.org frei und für alle zugänglich machte, folgte 2003 prompt ein superprovisorisches Verbot. Der Vorwurf lautete «Raubkopieren» – dabei ging es aus meiner Sicht um den freien Zugang zu behördlich geprüften Arzneimittelinformationen. Damit begann ein Rechtsstreit, der mich – und die Frage nach dem freien Zugang zu medizinischem Wissen – durch sämtliche Instanzen führen sollte.

Das Zivilgericht Basel-Stadt hob das Verbot bereits 2004 auf: Behördlich geprüfte Arzneimittelinformationen sind kein urheberrechtlich geschütztes Werk. 2007 wurde die Klage vollumfänglich abgewiesen, 2008 bestätigte das Bundesgericht diesen Entscheid letztinstanzlich ([Urteil 4A 404/2007](#)). Für mich war das ein entscheidendes Signal für den freien Zugang zu medizinischem Wissen.

Parallel dazu prüfte die Wettbewerbskommission (WEKO) den Markt. Schon 2005 kam sie in ihrer [Vorabklärung](#) zum Schluss, dass der damalige Anbieter marktbeherrschend war. 2016 verhängte die WEKO eine Sanktion von rund 4,55 Millionen Franken wegen missbräuchlicher Verhaltensweisen des marktbeherrschenden Anbieters, darunter Exklusivklauseln gegenüber Softwarehäusern ([Verfügung 32-0249](#)). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte 2022 wesentliche Teile des Entscheids und reduzierte die Sanktion auf rund 3,78 Millionen Franken ([Urteil B-2597/2017](#)). Das Bundesgericht schränkte die festgestellten Verstösse 2025 deutlich ein und wies die Sache zur Neuberechnung der Sanktion zurück ([Urteil 2C 244/2022](#)). Bestehen blieb das Verbot, Softwarehäusern die Verwendung gleich strukturierter Drittdaten zu untersagen: Eine solche Klausel verschliesse den Markt teilweise und behindere die Entwicklung von Wettbewerb, hielt das Gericht fest. Für mich heisst das unmissverständlich: mehr Konkurrenz, weniger abgeschottete Monopole – Arzneimittelinformationen brauchen Offenheit statt Exklusivität.

Warum erzähle ich Ihnen das? Weil dieser über zwei Jahrzehnte dauernde Streit weit über meinen Einzelfall hinausweist. Er handelt von einer Frage, die unsere gesamte Gesundheitsbranche betrifft: Wem gehören die Daten, auf denen Versorgung, Forschung und Innovation aufbauen?

Daten sind die Grundlage, der Nährboden für Innovation und für die Weiterentwicklung neuer Ideen. Was im Auftrag des Staates geprüft wird, gehört in die Public Domain – quelloffen und frei nutzbar für alle. Werden solche Daten hinter Exklusivverträgen und Lizenzgebühren eingeschlossen, ersticken wir genau jene Innovation, die wir im Schweizer Gesundheitswesen so dringend benötigen.

Mein Fall zeigt: Ein langer Atem lohnt sich. Über zwanzig Jahre, mehrere Gerichtsverfahren, zwei Kartelluntersuchungen – das alles hat sich mehr als gelohnt: dass öffentlich geprüftes Wissen öffentlich nutzbar ist.

Auch grosse Technologieunternehmen verbinden Wettbewerb und Zusammenarbeit: Google investierte bereits 2015 gemeinsam mit Fidelity rund eine Milliarde US-Dollar in SpaceX. In den KI-Entwickler Anthropic investieren sowohl Google als auch Amazon Milliardenbeträge – obwohl Google im KI-Markt mit Anthropic konkurriert. Wettbewerb und Zusammenarbeit schliessen sich also nicht aus. Abschottende Monopole dagegen verhindern Innovation und halten die Kosten hoch.

Bessere Rahmenbedingungen beginnen nicht erst in Bundesbern. Sie beginnen bei der Frage, ob wir Wissen und Software als gemeinsame Allmende begreifen – als Open Source und Public Domain, die allen nützt – oder als Festung, die einige wenige schützt.

Das Schweizer Gesundheitswesen krankt an einem zu starren Gärtchen-Denken: mein Gärtchen, dein Gärtchen. Um gemeinsam weiterzukommen, müssen wir Wissen teilen. Mein Aufruf an Sie: Machen Sie geeignete, nicht personenbezogene Daten frei zugänglich und öffnen Sie Ihren Code dort, wo es den Patienten dient und rechtlich möglich ist. Setzen Sie auf offene Schnittstellen, Open Source und die Public Domain statt auf Exklusivklauseln. Gerade im Gesundheitswesen gilt: Sharing is Caring – Teilen ist gelebte Fürsorge. Wer heute auf Offenheit setzt, schafft die Rahmenbedingungen für die Innovation von morgen.

ZENO DAVATZ
ywesee GmbH

► In dieser Rubrik äussern Fachleute aus Gesundheit und Life Sciences ihre Meinung zu aktuellen Themen.